# SOLICITAÇÃO DE EXAME NEUROLÓGICO

**PACIENTE : TESTE IMPRESSAO QA**

**DATA DE EMISSÃO :** 19/10/2026

**CLÍNICA / INSTITUIÇÃO :** +DOUTOR CLINICA E LABORATÓRIO

Av. Papa João Paulo I, 3086 - Jardim Pres . Dutra , Guarulhos /SP - CEP: 07174-000

Tel : 11 98958 0281 | 11 94772 5760

Documento emitido por Juan Marcelo Cabello Merida (CRM 161792 SP)

Verifique a assinatura digital

Código : A6KXCC

Código de acesso : 5877

☑ Avaliação da força de preensão bilateral dos membros superiores (dinamômetro ).

**Relatório Médico — este exame inclui :**

1. RELATÓRIO MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO CLÍNICA
2. JUSTIFICATIVA NEUROLÓGICA E FUNCIONAL
3. JUSTIFICATIVA PARA LAUDO MÉDICO ESPECIALIZADO
4. JUSTIFICATIVA MÉDICO -PERICIAL
5. REQUISITOS DO RELATÓRIO E LAUDO DO EXAME
6. CONCLUSÃO E SOLICITAÇÃO MÉDICA

**CID**

—

**ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO**

Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001) por **JUAN MARCELO CABELLO MERIDA LTDA** (CNPJ 23.420.313/0001-02 - CRM 161792 SP) em 20/10/2026 11:07:24.
Verifique a autenticidade e integridade do documento em **validar.iti.gov.br**.

# RELATÓRIO MÉDICO E JUSTIFICATIVA DE EXAME ESPECIALIZADO

## DINAMOMETRIA MUSCULAR DE MEMBROS SUPERIORES BILATERAL

---

**Finalidade:** Avaliação Neurológica, Funcional e Médico-Pericial

**Paciente:** TESTE IMPRESSAO QA

**Data:** 19 de outubro de 2026

**Exame solicitado:** Dinamometria muscular de membros superiores bilateral, com avaliação quantitativa da força muscular, análise comparativa entre os membros direito e esquerdo e emissão de laudo médico interpretativo especializado.

### 1. RELATÓRIO MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO CLÍNICA

Solicito a realização de dinamometria muscular bilateral dos membros superiores, com a finalidade de obter parâmetros objetivos, quantitativos e reprodutíveis da força muscular, permitindo a investigação de possíveis déficits motores, assimetrias funcionais e comprometimentos neuromusculares.

A avaliação dinamométrica constitui método complementar de mensuração da força muscular, particularmente útil na análise da força de preensão palmar e, conforme o equipamento utilizado, de grupos musculares específicos dos membros superiores.

O exame poderá contribuir para a investigação e o acompanhamento de alterações motoras associadas a neuropatias periféricas, polineuropatias inflamatórias e desmielinizantes, radiculopatias cervicais, síndromes compressivas de nervos periféricos, miopatias, doenças do neurônio motor, sequelas neurológicas centrais e afecções musculoesqueléticas.

Sua realização justifica-se pela necessidade de documentar quantitativamente a função motora, permitindo correlação com a semiologia neurológica, exame físico e demais exames complementares, quando disponíveis.

### 2. JUSTIFICATIVA NEUROLÓGICA E FUNCIONAL

A mensuração da força muscular dos membros superiores apresenta relevância na avaliação de possíveis alterações do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, unidade motora e aparelho musculoesquelético.

Solicita-se avaliação dos seguintes parâmetros:

1. Força de preensão palmar bilateral.
2. Comparação quantitativa entre os membros superiores direito e esquerdo.
3. Identificação de possíveis assimetrias de força muscular.
4. Avaliação de grupos musculares específicos, quando clinicamente indicada e tecnicamente disponível.
5. Análise da influência da dominância manual sobre os resultados.
6. Investigação de possíveis limitações funcionais relacionadas à redução da força muscular.
7. Documentação objetiva para acompanhamento evolutivo e avaliação da resposta terapêutica.

A interpretação deverá considerar fatores como idade, sexo, dominância manual, presença de dor, limitações articulares, fadiga, condições clínicas e metodologia utilizada.

### 3. JUSTIFICATIVA PARA LAUDO MÉDICO ESPECIALIZADO

Solicito expressamente que o exame seja acompanhado de laudo médico interpretativo, preferencialmente elaborado e assinado por médico especialista em uma das seguintes áreas:

**I – NEUROLOGIA**

Para correlação dos resultados com a semiologia neurológica, investigação de déficits motores, neuropatias periféricas, radiculopatias cervicais, doenças neuromusculares e comprometimentos do sistema nervoso central.

**II – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

Para avaliação de alterações musculoesqueléticas, comprometimentos articulares, lesões musculotendíneas e limitações biomecânicas capazes de interferir na produção de força muscular.

**III – MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO (FISIATRIA)**

Para interpretação da capacidade funcional, desempenho muscular, limitações motoras, repercussões nas atividades de vida diária e necessidades de reabilitação.

A necessidade de interpretação médica especializada fundamenta-se na importância de distinguir déficits de força de origem neurogênica, miopática, musculoesquelética ou associados a fatores álgicos e funcionais.

A mensuração dinamométrica isolada não estabelece diagnóstico etiológico e não substitui a avaliação médica especializada.

### 4. JUSTIFICATIVA MÉDICO-PERICIAL

Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001) por JUAN MARCELO CABELLO MERIDA LTDA (CNPJ 23.420.313/0001-02 - CRM-SP 161792) em 20/10/2026 11:07:25. Verifique a autenticidade e integridade do documento em validar.iti.gov.br.

O exame também possui finalidade médico-pericial, visando à obtenção de dados objetivos que possam subsidiar a análise da capacidade funcional dos membros superiores.

A documentação quantitativa da força muscular poderá contribuir para a caracterização de alterações motoras, acompanhamento evolutivo e investigação de limitações funcionais com possíveis repercussões nas atividades habituais e profissionais.

Para essa finalidade, os resultados deverão ser interpretados em conjunto com a história clínica, exame físico, exames complementares e exigências específicas da atividade laborativa.

Ressalta-se que a dinamometria, isoladamente, não comprova incapacidade laborativa, incapacidade permanente ou grau de deficiência, sendo necessária avaliação médico-pericial abrangente.

**5. REQUISITOS DO RELATÓRIO E LAUDO DO EXAME**

Solicito que o documento final contenha:

1. Identificação do equipamento e protocolo de avaliação.
2. Valores quantitativos da força muscular dos membros superiores, com unidades de medida.
3. Mensuração da força de preensão palmar direita e esquerda.
4. Registro de medidas repetidas e análise da variabilidade dos resultados.
5. Comparação bilateral, considerando a dominância manual.
6. Identificação e quantificação de possíveis assimetrias ou déficits de força.
7. Interpretação em relação aos parâmetros de referência apropriados, quando disponíveis.
8. Descrição de fatores que possam interferir nas mensurações.
9. Correlação clínica e análise das possíveis repercussões funcionais.
10. Conclusão médica fundamentada, com identificação profissional, CRM, especialidade e assinatura do médico responsável.

**6. CONCLUSÃO E SOLICITAÇÃO MÉDICA**

Diante da necessidade de investigação objetiva da força muscular e de documentação funcional, justifico e solicito a realização de DINAMOMETRIA MUSCULAR DE MEMBROS SUPERIORES BILATERAL, acompanhada de laudo médico interpretativo especializado.

Para esta solicitação, prioriza-se a emissão do laudo por médico especialista em NEUROLOGIA, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ou MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO (FISIATRIA), em razão da finalidade neurológica, funcional e médico-pericial da avaliação.

Ressalto que o relatório técnico de mensuração dinamométrica e o laudo médico interpretativo possuem finalidades distintas. A interpretação médica especializada é solicitada para proporcionar adequada correlação clínico-funcional, maior consistência técnico-científica e subsídios à tomada de decisões diagnósticas, terapêuticas e médico-periciais.

**Documento emitido por Juan Marcelo Cabello Merida (CRM 161792 SP)**

Verifique a assinatura digital

**Código: A6KXCC**

**Código de acesso: 5877**

**Dr. Juan Marcelo Cabello Merida**

Médico Neurologista Clínico · Médico Neurofisiologista

Médico concursado em Neurologia · Médico Perito Judicial do Estado de São Paulo

Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001) por **JUAN MARCELO CABELLO MERIDA LTDA** (CNPJ 23.420.313/0001-02 - CRM-SP 161792) em 20/10/2026 11:07:25.

Verifique a autenticidade e integridade do documento em **validar.iti.gov.br**.

# SOLICITAÇÃO DE EXAME NEUROLÓGICO

**PACIENTE : TESTE IMPRESSAO QA**

**DATA DE EMISSÃO :** 19/10/2026

**CLÍNICA / INSTITUIÇÃO :** +DOUTOR CLINICA E LABORATÓRIO

Av. Papa João Paulo I, 3086 - Jardim Pres . Dutra , Guarulhos /SP - CEP: 07174-000

Tel : 11 98958 0281 | 11 94772 5760

Documento emitido por Juan Marcelo Cabello Merida (CRM 161792 SP)

Verifique a assinatura digital

Código : A6KXCC

Código de acesso : 5877

☑ Avaliação do equilíbrio clínico .

**Relatório Médico — este exame inclui :**

1. RELATÓRIO MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO CLÍNICA
2. JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA DO TESTE TIMED UP AND GO (TUG)
3. JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA DA ESCALA DE EQUILÍBRIO DE BERG (BBS)
4. JUSTIFICATIVA PARA LAUDO MÉDICO ESPECIALIZADO
5. JUSTIFICATIVA DA PARTICIPAÇÃO MÉDICA NA AVALIAÇÃO
6. JUSTIFICATIVA MÉDICO -PERICIAL
7. REQUISITOS DO RELATÓRIO E LAUDO DO EXAME
8. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O MODELO DE EXAME APRESENTADO
9. CONCLUSÃO E SOLICITAÇÃO MÉDICA

**CID**

—

**ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO**

Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001) por **JUAN MARCELO CABELLO MERIDA LTDA** (CNPJ 23.420.313/0001-02 - CRM 161792 SP) em 20/10/2026 11:07:26.
Verifique a autenticidade e integridade do documento em **validar.iti.gov.br**.

# RELATÓRIO MÉDICO E JUSTIFICATIVA DE EXAME ESPECIALIZADO

## AVALIAÇÃO CLÍNICA DO EQUILÍBRIO E RISCO DE QUEDAS

### TESTE TIMED UP AND GO (TUG) E ESCALA DE EQUILÍBRIO DE BERG (BBS)

---

**Finalidade:** Avaliação Neurológica, Vestibular, Postural, Funcional e Médico-Pericial

**Paciente:** TESTE IMPRESSAO QA

**Data:** 19 de outubro de 2026

**Exames solicitados:**

- Teste Timed Up and Go (TUG).
- Escala de Equilíbrio de Berg (Berg Balance Scale – BBS).

**Solicitação complementar:** Emissão de laudo médico interpretativo especializado, preferencialmente por médico neurologista, otorrinolaringologista, ortopedista e traumatologista ou especialista em Medicina Física e Reabilitação (Fisiatria).

**1. RELATÓRIO MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO CLÍNICA**

Solicito a realização de AVALIAÇÃO CLÍNICA DO EQUILÍBRIO E RISCO DE QUEDAS, POR MEIO DO TESTE TIMED UP AND GO (TUG) E DA ESCALA DE EQUILÍBRIO DE BERG (BBS), com a finalidade de investigar possíveis alterações do controle postural, estabilidade corporal, coordenação motora, mobilidade funcional e desempenho da marcha.

A avaliação do equilíbrio constitui instrumento complementar relevante na investigação de comprometimentos dos sistemas vestibular, cerebelar, proprioceptivo, sensório-motor e musculoesquelético.

O equilíbrio corporal depende da adequada integração das aferências vestibulares, visuais e somatossensoriais, associada ao processamento central e às respostas motoras necessárias para a manutenção da estabilidade postural.

Alterações nesses mecanismos podem ocasionar instabilidade corporal, dificuldades de marcha, vertigem, tontura, alterações da coordenação, comprometimento das transferências posturais e aumento do risco de quedas.

A realização dos testes poderá contribuir para a investigação e o acompanhamento de condições clínicas como:

1. Síndromes vestibulares periféricas e centrais.
2. Ataxias cerebelares e distúrbios da coordenação motora.
3. Doença de Parkinson e outras síndromes parkinsonianas.
4. Polineuropatias periféricas com comprometimento sensitivo ou proprioceptivo.
5. Sequelas motoras de acidentes vasculares cerebrais.
6. Esclerose múltipla e outras doenças desmielinizantes.
7. Alterações da marcha decorrentes de doenças neuromusculares.
8. Comprometimentos osteoarticulares e musculoesqueléticos.
9. Distúrbios do controle postural e da mobilidade funcional.
10. Condições clínicas associadas a instabilidade e risco de quedas.

**2. JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA DO TESTE TIMED UP AND GO (TUG)**

O Timed Up and Go (TUG) constitui instrumento padronizado de avaliação da mobilidade funcional, permitindo mensurar o tempo necessário para que o paciente se levante de uma cadeira, caminhe aproximadamente três metros, realize mudança de direção, retorne ao ponto inicial e se sente novamente.

Sua aplicação tem como objetivos:

1. Avaliar a mobilidade funcional global.
2. Investigar dificuldades nas transferências posturais.
3. Analisar o desempenho durante a marcha e as mudanças de direção.
4. Identificar lentificação motora e limitações locomotoras.
5. Observar instabilidade postural durante a execução da tarefa.
6. Registrar o tempo total de execução em segundos.
7. Auxiliar na identificação de limitações funcionais associadas ao risco de quedas.
8. Permitir acompanhamento evolutivo e comparação entre avaliações sucessivas.

A interpretação deverá considerar idade, condições clínicas, uso de dispositivos auxiliares, necessidade de assistência, velocidade de marcha, limitações motoras e metodologia empregada.

Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001) por JUAN MARCELO CABELLO MERIDA LTDA (CNPJ 23.420.313/0001-02 - CRM-SP 161792) em 20/10/2026 11:07:27. Verifique a autenticidade e integridade do documento em validar.iti.gov.br.

O resultado do TUG não deverá ser interpretado isoladamente como diagnóstico de doença vestibular, neurológica ou incapacidade funcional permanente.

**3. JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA DA ESCALA DE EQUILÍBRIO DE BERG (BBS)**

A Escala de Equilíbrio de Berg (Berg Balance Scale – BBS) constitui instrumento clínico padronizado de avaliação do equilíbrio funcional, composto por 14 tarefas relacionadas à manutenção da postura, transferências, mudanças de posição e controle do centro de massa corporal.

Cada tarefa recebe pontuação de zero a quatro, totalizando pontuação máxima de 56 pontos.

Solicito avaliação dos seguintes componentes:

1. Passagem da posição sentada para ortostática.
2. Permanência em pé sem apoio.
3. Permanência sentada sem apoio dorsal.
4. Transição da posição ortostática para sentada.
5. Transferências entre cadeiras.
6. Permanência em pé com olhos fechados.
7. Permanência em pé com os pés juntos.
8. Alcance anterior com membro superior estendido.
9. Capacidade de recolher objeto do chão.
10. Rotação do tronco para olhar sobre os ombros.
11. Giro corporal de 360 graus.
12. Apoio alternado dos pés sobre degrau.
13. Permanência em posição tandem.
14. Permanência em apoio unipodal.

A avaliação permite caracterizar o desempenho funcional do equilíbrio em diferentes condições posturais, identificando tarefas com maior dificuldade e possíveis limitações da estabilidade corporal.

A pontuação obtida deverá ser interpretada de acordo com as características clínicas do paciente e as limitações do instrumento, evitando conclusões diagnósticas baseadas exclusivamente no escore total.

**4. JUSTIFICATIVA PARA LAUDO MÉDICO ESPECIALIZADO**

Solicito expressamente que os resultados do TUG e da Escala de Berg sejam acompanhados de laudo médico interpretativo especializado, preferencialmente elaborado e assinado por médico de uma das seguintes especialidades:

**I – NEUROLOGIA**

Para correlação dos resultados com a semiologia neurológica, investigação de comprometimentos cerebelares, extrapiramidais, proprioceptivos, neuromusculares e alterações do sistema nervoso central ou periférico.

A avaliação neurológica poderá considerar força muscular, tônus, reflexos osteotendíneos, sensibilidade profunda, coordenação motora, sinais cerebelares e características da marcha.

**II – OTORRINOLARINGOLOGIA**

Para investigação de síndromes vestibulares, vertigem, tontura e possíveis alterações dos mecanismos vestibulares envolvidos no controle postural, com indicação de exames otoneurológicos complementares quando necessários.

**III – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

Para correlação das alterações do equilíbrio com comprometimentos osteoarticulares, alterações biomecânicas, limitações articulares e doenças musculoesqueléticas que possam interferir na estabilidade postural e na marcha.

**IV – MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO (FISIATRIA)**

Para avaliação especializada da mobilidade funcional, desempenho postural, limitações motoras, independência nas atividades de vida diária, necessidades de reabilitação e repercussões funcionais.

**5. JUSTIFICATIVA DA PARTICIPAÇÃO MÉDICA NA AVALIAÇÃO**

Considerando a finalidade neurológica e médico-pericial desta solicitação, requer-se interpretação diagnóstica médica especializada, com correlação dos resultados obtidos nos testes com a história clínica e o exame físico.

A participação médica é especialmente relevante para:

1. Investigar possíveis causas neurológicas, vestibulares e musculoesqueléticas da instabilidade.
2. Correlacionar os resultados dos testes com a semiologia neurológica.
3. Diferenciar limitações relacionadas à força muscular, coordenação, propriocepção, dor ou mobilidade articular.
4. Avaliar possíveis interferências medicamentosas e condições clínicas sistêmicas.
5. Identificar discrepâncias entre os resultados dos diferentes instrumentos.
6. Determinar a necessidade de investigação complementar.
7. Interpretar as repercussões funcionais das alterações identificadas.
8. Elaborar conclusão diagnóstica fundamentada, respeitando os limites dos testes.

Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001) por JUAN MARCELO CABELLO MERIDA LTDA (CNPJ 23.420.313/0001-02 - CRM-SP 161792) em 20/10/2026 11:07:27. Verifique a autenticidade e integridade do documento em validar.iti.gov.br.

A execução dos testes TUG e Berg não constitui atividade exclusiva do médico. Profissionais de saúde legalmente habilitados, incluindo fisioterapeutas, podem realizar avaliações funcionais dentro de suas competências.
Entretanto, para esta solicitação, requer-se laudo médico interpretativo especializado, em razão da finalidade diagnóstica, neurológica e médico-pericial pretendida.

**6. JUSTIFICATIVA MÉDICO-PERICIAL**

A avaliação possui também finalidade médico-pericial, visando à documentação padronizada da mobilidade funcional e do desempenho do equilíbrio estático e dinâmico.
Os resultados poderão contribuir para:

1. Identificação de alterações da estabilidade postural.
2. Caracterização de dificuldades nas transferências posturais.
3. Investigação de limitações da marcha e mobilidade.
4. Documentação do tempo de execução do TUG.
5. Registro da pontuação total e individual das tarefas da Escala de Berg.
6. Identificação de fatores associados ao risco de quedas.
7. Acompanhamento evolutivo das alterações funcionais.
8. Subsídio à avaliação da capacidade funcional e laborativa, considerando as exigências específicas da atividade profissional.

Os resultados deverão ser interpretados em conjunto com a história clínica, exame neurológico, avaliação musculoesquelética e demais exames complementares.
Os testes TUG e Berg, isoladamente, não comprovam incapacidade laborativa, incapacidade permanente ou grau de deficiência.

**7. REQUISITOS DO RELATÓRIO E LAUDO DO EXAME**

Solicito que o documento final contenha:

1. Identificação dos protocolos empregados.
2. Registro do tempo de execução do TUG, expresso em segundos.
3. Descrição das condições de realização do TUG, incluindo uso de apoio, assistência e dispositivos auxiliares.
4. Pontuação individual das 14 tarefas da Escala de Berg.
5. Pontuação total da Escala de Berg, com máximo de 56 pontos.
6. Identificação das tarefas com maior dificuldade.
7. Descrição de alterações observadas durante a marcha e as transferências posturais.
8. Análise das possíveis repercussões funcionais.
9. Correlação clínica entre os resultados do TUG e da Escala de Berg.
10. Identificação e discussão de resultados discrepantes, quando presentes.
11. Interpretação clínica fundamentada, incluindo as limitações dos métodos.
12. Conclusão médica especializada, com identificação profissional, CRM, especialidade e assinatura do médico responsável.

**8. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O MODELO DE EXAME APRESENTADO**

O modelo de avaliação apresentado utiliza conjuntamente o Timed Up and Go (TUG) e a Escala de Equilíbrio de Berg (BBS).
A associação desses instrumentos permite documentar aspectos complementares da mobilidade e do equilíbrio funcional.
O TUG fornece uma medida temporal da execução de uma tarefa de mobilidade, enquanto a Escala de Berg avalia o desempenho em diferentes tarefas posturais.
A interpretação conjunta é relevante, especialmente quando houver divergência entre o tempo de execução do TUG e a pontuação da Escala de Berg.
Nessas situações, recomenda-se verificar a precisão do registro, as condições de execução, a necessidade de auxílio e os possíveis fatores clínicos que possam explicar os resultados.

**9. CONCLUSÃO E SOLICITAÇÃO MÉDICA**

Diante da necessidade de investigação de possíveis alterações do equilíbrio corporal, instabilidade postural, comprometimentos neurológicos e vestibulares e limitações da mobilidade funcional, JUSTIFICO E SOLICITO A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CLÍNICA DO EQUILÍBRIO E RISCO DE QUEDAS, COM APLICAÇÃO DO TESTE TIMED UP AND GO (TUG) E DA ESCALA DE EQUILÍBRIO DE BERG (BBS), acompanhada de laudo médico interpretativo especializado.
Para esta solicitação, prioriza-se a avaliação clínica e a emissão do laudo por médico especialista em NEUROLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ou MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO (FISIATRIA), em razão da finalidade neurológica, vestibular, funcional e médico-pericial.
Ressalto que o relatório técnico de aplicação dos testes e o laudo médico interpretativo possuem finalidades distintas.
A interpretação médica especializada é solicitada para assegurar adequada correlação clínico-neurológica e funcional, maior consistência técnico-científica e subsídios à tomada de decisões diagnósticas, terapêuticas e médico-periciais.
A presente solicitação tem por objetivo assegurar avaliação padronizada e tecnicamente fundamentada do equilíbrio estático e dinâmico, da mobilidade funcional e dos fatores associados ao risco de quedas, com especial atenção às repercussões sobre a capacidade

Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001) por JUAN MARCELO CABELLO MERIDA LTDA (CNPJ 23.420.313/0001-02 - CRM-SP 161792) em 20/10/2026 11:07:27. Verifique a autenticidade e integridade do documento em validar.iti.gov.br.

funcional global do paciente.

**Documento emitido por Juan Marcelo Cabello Merida (CRM 161792 SP)**

Verifique a assinatura digital

**Código: A6KXCC**

**Código de acesso: 5877**

**Dr. Juan Marcelo Cabello Merida**

Médico Neurologista Clínico · Médico Neurofisiologista

Médico concursado em Neurologia · Médico Perito Judicial do Estado de São Paulo

Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001) por **JUAN MARCELO CABELLO MERIDA LTDA** (CNPJ 23.420.313/0001-02 - CRM-SP 161792) em 20/10/2026 11:07:27.
Verifique a autenticidade e integridade do documento em **validar.iti.gov.br**.

# SOLICITAÇÃO DE EXAME NEUROLÓGICO

**PACIENTE : TESTE IMPRESSAO QA**

**DATA DE EMISSÃO :** 19/10/2026

**CLÍNICA / INSTITUIÇÃO :** +DOUTOR CLINICA E LABORATÓRIO

Av. Papa João Paulo I, 3086 - Jardim Pres . Dutra , Guarulhos /SP - CEP: 07174-000

Tel : 11 98958 0281 | 11 94772 5760

Documento emitido por Juan Marcelo Cabello Merida (CRM 161792 SP)

Verifique a assinatura digital

Código : A6KXCC

Código de acesso : 5877

☑ Estesiômetro MMII

**Relatório Médico — este exame inclui :**

1. RELATÓRIO MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO CLÍNICA
2. JUSTIFICATIVA NEUROLÓGICA E SENSITIVA
3. JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO E LAUDO MÉDICO ESPECIALIZADO
4. JUSTIFICATIVA DA PARTICIPAÇÃO MÉDICA NA AVALIAÇÃO
5. JUSTIFICATIVA MÉDICO -PERICIAL
6. REQUISITOS DO RELATÓRIO E LAUDO DO EXAME
7. CONCLUSÃO E SOLICITAÇÃO MÉDICA

**CID**

—

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001) por **JUAN MARCELO CABELLO MERIDA LTDA** (CNPJ 23.420.313/0001-02 - CRM 161792 SP) em 20/10/2026 11:07:27.
Verifique a autenticidade e integridade do documento em **validar.iti.gov.br**.

# RELATÓRIO MÉDICO E JUSTIFICATIVA DE EXAME ESPECIALIZADO

## ESTESIOMETRIA DE MEMBROS INFERIORES BILATERAL

---

**Finalidade:** Avaliação Neurológica, Sensitiva, Funcional e Médico-Pericial

**Paciente:** TESTE IMPRESSAO QA

**Data:** 19 de outubro de 2026

**Exame solicitado:** Estesiometria de membros inferiores direito e esquerdo, com avaliação sensitiva cutânea, investigação de possíveis alterações da sensibilidade superficial, análise comparativa bilateral e emissão de laudo médico interpretativo especializado.

Especialidades médicas preferenciais para realização da avaliação clínica e emissão do laudo: Neurologia, Ortopedia e Traumatologia ou Medicina Física e Reabilitação (Fisiatria).

### 1. RELATÓRIO MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO CLÍNICA

Solicito a realização de ESTESIOMETRIA DE MEMBROS INFERIORES BILATERAL, utilizando instrumento apropriado e metodologia padronizada, preferencialmente monofilamentos de Semmes-Weinstein, para investigação de possíveis alterações da sensibilidade cutânea e caracterização funcional da percepção de estímulos mecânicos nos membros inferiores.

A estesiometria constitui método complementar de avaliação sensitiva, permitindo estimar limiares de percepção ao estímulo tátil e identificar alterações compatíveis com comprometimento da sensibilidade superficial, sendo particularmente relevante na avaliação plantar e na investigação do risco de lesões cutâneas associadas à perda de sensibilidade protetora.

O exame poderá contribuir para a investigação e o acompanhamento de condições clínicas como:

1. Polineuropatias periféricas sensitivas, incluindo neuropatia diabética.
2. Polineuropatias inflamatórias e desmielinizantes.
3. Neuropatias metabólicas e tóxicas.
4. Radiculopatias lombossacras com manifestações sensitivas.
5. Síndromes compressivas de nervos periféricos, incluindo síndrome do túnel do tarso.
6. Lesões traumáticas de nervos periféricos.
7. Alterações sensitivas relacionadas a lesões medulares.
8. Sequelas neurológicas de acidentes vasculares cerebrais.
9. Distúrbios sensitivos associados a doenças musculoesqueléticas.
10. Alterações da sensibilidade com repercussões sobre a marcha, o equilíbrio e a integridade cutânea dos pés.

A realização do exame justifica-se pela necessidade de documentar a distribuição e a intensidade das alterações da sensibilidade tátil, permitindo correlação com a semiologia neurológica, exame físico e exames complementares, quando disponíveis.

### 2. JUSTIFICATIVA NEUROLÓGICA E SENSITIVA

A avaliação estesiométrica dos membros inferiores apresenta relevância na investigação de possíveis alterações das vias sensitivas periféricas e centrais.

Solicito avaliação bilateral, contemplando:

1. Sensibilidade tátil superficial: determinação do limiar de percepção ao estímulo mecânico aplicado à pele.
2. Sensibilidade plantar: avaliação de pontos padronizados nas regiões plantares, incluindo hálux e cabeças metatarsais.
3. Distribuição anatômica: avaliação de regiões cutâneas correspondentes aos territórios dos nervos fibular superficial, fibular profundo, tibial, sural e safeno.
4. Distribuição dermatomérica: análise de regiões relacionadas aos dermátomos lombares e sacrais, especialmente L2, L3, L4, L5 e S1, conforme indicação clínica.
5. Comparação bilateral: identificação de possíveis assimetrias sensitivas entre os membros inferiores.
6. Investigação de hipoestesia: redução da percepção sensitiva em regiões examinadas.
7. Investigação de anestesia tátil: ausência de percepção dos estímulos testados, respeitando os limites do instrumento.
8. Correlação funcional: investigação das possíveis repercussões sensitivas sobre a marcha, o equilíbrio, a mobilidade e a integridade cutânea dos pés.

A estesiometria com monofilamentos avalia predominantemente a percepção tátil à pressão. A caracterização de hiperalgesia, alodinia, sensibilidade térmica, vibratória ou proprioceptiva poderá exigir outros testes específicos.

Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001) por JUAN MARCELO CABELLO MERIDA LTDA (CNPJ 23.420.313/0001-02 - CRM-SP 161792) em 20/10/2026 11:07:28. Verifique a autenticidade e integridade do documento em validar.iti.gov.br.

### 3. JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO E LAUDO MÉDICO ESPECIALIZADO

Solicito expressamente que a estesiometria seja integrada a uma avaliação clínica médica e acompanhada de LAUDO MÉDICO INTERPRETATIVO ESPECIALIZADO, preferencialmente elaborado e assinado por médico de uma das seguintes especialidades:

**I – NEUROLOGIA**

Para interpretação dos resultados em correlação com a semiologia neurológica, investigação de neuropatias periféricas, polineuropatias, radiculopatias lombossacras, lesões de nervos periféricos e comprometimentos sensitivos de origem central.

A avaliação neurológica poderá considerar:

- Distribuição topográfica das alterações sensitivas.
- Correspondência com territórios de inervação periférica.
- Correlação com dermátomos lombares e sacrais.
- Presença de parestesias, disestesias, hipoestesias e outras manifestações sensitivas.
- Associação com déficits motores, alterações dos reflexos osteotendíneos e comprometimentos funcionais.
- Necessidade de investigação complementar, incluindo eletroneuromiografia, quando clinicamente indicada.

**II – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

Para correlação dos achados sensitivos com lesões traumáticas, síndromes compressivas, alterações osteoarticulares, doenças degenerativas da coluna lombossacra e comprometimentos musculoesqueléticos associados a manifestações neurológicas.

**III – MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO (FISIATRIA)**

Para interpretação das alterações sensitivas no contexto da capacidade funcional, marcha, equilíbrio, mobilidade, independência nas atividades de vida diária e necessidades de reabilitação.

A necessidade de laudo médico especializado fundamenta-se na importância de integrar os achados estesiométricos à história clínica, ao exame neurológico e aos demais exames complementares.

A identificação de alterações sensitivas por meio de estesiometria, isoladamente, não permite estabelecer com segurança a etiologia, localização anatômica precisa ou gravidade global de uma doença neurológica.

### 4. JUSTIFICATIVA DA PARTICIPAÇÃO MÉDICA NA AVALIAÇÃO

Considerando a finalidade neurológica e médico-pericial desta solicitação, recomenda-se que a interpretação diagnóstica seja realizada por médico habilitado, preferencialmente especialista nas áreas anteriormente mencionadas.

A participação médica é especialmente relevante para:

1. Realizar a correlação entre os achados sensitivos e a história clínica.
2. Identificar padrões de distribuição compatíveis com polineuropatias, radiculopatias lombossacras ou lesões centrais.
3. Diferenciar alterações sensitivas de possíveis fatores locais, dermatológicos, vasculares ou musculoesqueléticos.
4. Integrar os resultados com a avaliação da força muscular, reflexos e demais modalidades sensitivas.
5. Determinar a necessidade de exames complementares e investigação etiológica.
6. Avaliar as possíveis repercussões clínicas e funcionais das alterações identificadas, incluindo o risco de lesões cutâneas nos pés.
7. Elaborar conclusão diagnóstica médica fundamentada, respeitando os limites do método.

Ressalta-se que a realização técnica da estesiometria não é atividade exclusiva do médico. Profissionais de saúde legalmente habilitados, como fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, também podem executar avaliações sensitivas dentro de suas competências.

Entretanto, para a finalidade específica desta solicitação, requer-se laudo médico interpretativo especializado, sem prejuízo da participação de outros profissionais habilitados na execução técnica do procedimento.

### 5. JUSTIFICATIVA MÉDICO-PERICIAL

A presente solicitação possui também finalidade médico-pericial, visando à obtenção de informações objetivamente documentadas e obtidas por metodologia padronizada sobre a sensibilidade cutânea dos membros inferiores.

A avaliação poderá contribuir para:

1. Identificação e documentação de alterações da sensibilidade tátil.
2. Caracterização da distribuição topográfica de déficits sensitivos.
3. Comparação entre os membros inferiores direito e esquerdo.
4. Investigação de possíveis repercussões funcionais relacionadas à perda de sensibilidade, incluindo sobre a marcha e o equilíbrio.
5. Acompanhamento evolutivo de doenças neurológicas e neuropatias periféricas.
6. Documentação de achados sensitivos relevantes para avaliações médico-periciais.
7. Correlação entre manifestações clínicas, resultados instrumentais e exames complementares.
8. Subsídio à análise da capacidade funcional e laborativa, considerando as exigências específicas da atividade profissional.

A estesiometria depende da resposta perceptiva do paciente e deve ser interpretada considerando colaboração, compreensão das instruções, técnica de aplicação e reprodutibilidade dos achados.

Ressalta-se que a estesiometria, isoladamente, não comprova incapacidade laborativa, incapacidade permanente ou grau de deficiência, sendo necessária avaliação clínica e médico-pericial abrangente.

### 6. REQUISITOS DO RELATÓRIO E LAUDO DO EXAME

Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001) por JUAN MARCELO CABELLO MERIDA LTDA (CNPJ 23.420.313/0001-02 - CRM-SP 161792) em 20/10/2026 11:07:28. Verifique a autenticidade e integridade do documento em validar.iti.gov.br.

Solicito que o documento final contenha:

1. Identificação do instrumento utilizado, metodologia e protocolo técnico.
2. Descrição dos monofilamentos empregados, quando aplicável, com seus respectivos valores de força.
3. Registro das regiões anatômicas examinadas nos membros inferiores, incluindo regiões plantares.
4. Mapeamento dos territórios sensitivos avaliados, incluindo nervos periféricos e dermátomos, quando clinicamente indicado.
5. Registro dos limiares de percepção tátil encontrados em cada região.
6. Comparação bilateral entre os membros inferiores direito e esquerdo.
7. Identificação de possíveis áreas de hipoestesia ou ausência de percepção tátil aos estímulos testados.
8. Descrição da consistência e reprodutibilidade das respostas, quando avaliadas.
9. Correlação dos achados com a semiologia neurológica e possíveis repercussões funcionais sobre a marcha e o equilíbrio.
10. Interpretação clínica fundamentada, incluindo limitações do método.
11. Conclusão médica especializada, sem extrapolação diagnóstica dos achados instrumentais.
12. Identificação profissional, número do CRM, especialidade e assinatura do médico responsável pelo laudo.

## 7. CONCLUSÃO E SOLICITAÇÃO MÉDICA

Diante da necessidade de investigação de possíveis alterações da sensibilidade superficial, caracterização topográfica de déficits sensitivos e documentação funcional, JUSTIFICO E SOLICITO A REALIZAÇÃO DE ESTESIOMETRIA DE MEMBROS INFERIORES BILATERAL, acompanhada de laudo médico interpretativo especializado.

Para esta solicitação, prioriza-se a avaliação clínica e a emissão do laudo por médico especialista em NEUROLOGIA, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ou MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO (FISIATRIA), em razão da finalidade neurológica, sensitiva, funcional e médico-pericial do procedimento.

Ressalto que o relatório técnico de mensuração estesiométrica e o laudo médico interpretativo possuem finalidades distintas.

A interpretação médica especializada é solicitada para assegurar adequada correlação clínico-neurológica, maior consistência técnico-científica e subsídios à tomada de decisões diagnósticas, terapêuticas e médico-periciais.

A presente solicitação tem por objetivo assegurar avaliação padronizada e tecnicamente fundamentada da sensibilidade cutânea dos membros inferiores, com especial atenção às possíveis alterações neurológicas, à distribuição dos déficits sensitivos e às repercussões sobre a marcha, o equilíbrio e a capacidade funcional do paciente.

**Documento emitido por Juan Marcelo Cabello Merida (CRM 161792 SP)**

Verifique a assinatura digital

**Código: A6KXCC**

**Código de acesso: 5877**

**Dr. Juan Marcelo Cabello Merida**

Médico Neurologista Clínico · Médico Neurofisiologista

Médico concursado em Neurologia · Médico Perito Judicial do Estado de São Paulo

Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001) por **JUAN MARCELO CABELLO MERIDA LTDA** (CNPJ 23.420.313/0001-02 - CRM-SP 161792) em 20/10/2026 11:07:28.

Verifique a autenticidade e integridade do documento em **validar.iti.gov.br**.